

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

CHECKLIST DE ALTA SEGURA

Critérios de Alta • Reconciliação Medicamentosa • Orientações ao Paciente • Continuidade do Cuidado

■ Alta segura reduz reinternação em 30 dias em até 30%. Comunicação eficaz e reconciliação medicamentosa são os pontos mais críticos.

1. CRITÉRIOS MÉDICOS DE ALTA HOSPITALAR

| Domínio                | Critério para Alta                                                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hemodinâmica           | PA estável sem vasopressor há ≥ 24h; FC e FR dentro de limites aceitáveis                       |
| Respiratório           | SpO <sub>2</sub> ≥ 92% em ar ambiente OU em O <sub>2</sub> suplementar domiciliar já programado |
| Temperatura            | Afebril há ≥ 24h OU febre explicada e em controle com tratamento domiciliar                     |
| Via oral / Alimentação | Tolerando dieta oral OU alimentação enteral domiciliar instalada e orientada                    |
| Dor                    | Controlada com analgesia oral OU estratégia domiciliar adequada definida                        |
| Infecção / ATB         | Em antibioticoterapia oral eficaz OU ciclo IV completado OU alta com ATB oral                   |
| Diagnóstico            | Diagnóstico principal estabelecido e tratado. Exames relevantes revisados                       |
| Suporte social         | Cuidador identificado, orientado e disponível. Ambiente domiciliar adequado                     |
| Seguimento             | Retorno ambulatorial agendado ou encaminhamento definido                                        |

■ **CONTRAINDICAÇÕES À ALTA:** instabilidade hemodinâmica, necessidade de O<sub>2</sub> > 4 L/min, febre de causa desconhecida, impossibilidade de via oral sem alternativa domiciliar, ausência total de rede de suporte.

2. RECONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA NA ALTA

■ 70% dos eventos adversos pós-alta são relacionados a medicamentos. A reconciliação reduz erros de omissão, duplicação e doses incorretas.

| Passo | Ação                                     | Detalhe                                                                              |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Listar medicamentos antes da internação  | Nome comercial e genérico, dose, frequência, via. Incluir fitoterápicos, suplementos |
| 2     | Comparar com prescrição hospitalar atual | Identificar o que foi suspenso, modificado, substituído ou adicionado                |
| 3     | Definir o que continua na alta           | Cada medicamento deve ter indicação clara. Eliminar duplicatas                       |

| Passo | Ação                                    | Detalhe                                                                        |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 4     | Explicar cada mudança ao paciente       | Linguagem simples. Mostrar embalagem se possível. Confirmar compreensão        |
| 5     | Prescrever em receituário legível       | Nome genérico + comercial, dose, via, frequência e duração. Evitar abreviações |
| 6     | Atentar para medicamentos de alto risco | Anticoagulantes, insulina, digitálicos, antiarrítmicos, imunossupressores      |
| 7     | Orientar sobre novos medicamentos       | Para que serve, como tomar, efeitos adversos possíveis, o que fazer se falhar  |

### 3. ORIENTAÇÕES AO PACIENTE — CONTEÚDO MÍNIMO

| Tema                  | O que Orientar                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnóstico           | Nome da doença em linguagem simples. O que causou, o que foi feito, o que vem depois |
| Medicamentos          | Lista impressa: nome, dose, horário, para que serve, duração do tratamento           |
| Dieta e hidratação    | Restrições alimentares, líquidos permitidos, alimentos a evitar                      |
| Atividade física      | O que pode e o que não pode fazer. Quando retomar atividades normais                 |
| Curativos e feridas   | Como fazer em casa, o que é normal, quando buscar ajuda                              |
| Sinais de alerta      | Sintomas que devem motivar retorno IMEDIATO à emergência                             |
| Retorno agendado      | Data, local, especialidade e o que levar (exames, receituários, cartão)              |
| Exames pendentes      | Culturas, biópsias, outros. Onde retirar o resultado e o que fazer com ele           |
| Vacinação             | Verificar cartão e orientar sobre pendências (influenza, pneumococo, COVID)          |
| Contato de emergência | Número do hospital, UPA de referência, orientação sobre SAMU (192)                   |

#### Sinais de Alerta — Retorno IMEDIATO à Emergência

| Situação Clínica     | Sintomas de Alarme                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cardiorrespiratório  | Falta de ar súbita ou progressiva, dor no peito, palpitações, edema rápido nos pés                   |
| Neurológico          | Confusão mental, fraqueza súbita em membros, dificuldade de falar, convulsão                         |
| Infeccioso / Séptico | Febre > 38,5°C, calafrios, piora do estado geral, hipotensão (tontura ao levantar)                   |
| Gastrointestinal     | Vômitos incoercíveis, dor abdominal intensa, sangramento (fezes escuras ou vermelhas)                |
| Renal / Urinário     | Redução importante do volume urinário, inchaço generalizado súbito                                   |
| Glicêmico            | Tontura, tremores, sudorese fria (hipoglicemia); sede intensa, urina muito frequente (hiperglicemia) |
| Anticoagulados       | Sangramento em qualquer local que não cessa, hematomas extensos, sangue na urina                     |

### 4. SUMÁRIO DE ALTA — CAMPOS OBRIGATÓRIOS

| Campo                           | Conteúdo Esperado                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Identificação                   | Nome completo, data de nascimento, prontuário, período de internação      |
| Diagnóstico principal e CID     | Diagnóstico definitivo ou de trabalho. Diagnósticos secundários ativos    |
| Resumo clínico                  | Motivo de internação, evolução, intercorrências, procedimentos realizados |
| Resultados de exames relevantes | Laboratoriais, culturas, imagens, histopatológico — com datas             |
| Medicamentos na alta            | Nome genérico, dose, via, frequência, duração de cada medicamento         |

| Campo                   | Conteúdo Esperado                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Pendências              | Culturas aguardando, biópsias, exames solicitados e não realizados      |
| Orientações específicas | Curativos, dieta, atividade, dispositivos (oxigênio, ostomias etc.)     |
| Retorno                 | Especialidade, local, data ou prazo. Critérios para retorno de urgência |
| Prognóstico             | Quando relevante para o médico de referência                            |
| Assinatura              | Nome completo, CRM, data e hora da alta                                 |

## 5. CHECKLIST DE ALTA — PREENCHER ANTES DE LIBERAR O PACIENTE

■ Aplicar este checklist em TODA alta hospitalar. Cada item deve ser verificado e marcado antes da liberação do paciente.

### ■ MÉDICO

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Critérios médicos de alta satisfeitos (sinais vitais estáveis, afebril, tolerando VO)          |
| <input type="checkbox"/> | Diagnóstico principal definido e documentado no prontuário                                     |
| <input type="checkbox"/> | Sumário de alta escrito, completo e assinado com CRM                                           |
| <input type="checkbox"/> | Exames pendentes identificados e paciente orientado sobre retirada dos resultados              |
| <input type="checkbox"/> | Receituário legível emitido com todos os medicamentos (genérico + dose + frequência + duração) |
| <input type="checkbox"/> | Reconciliação medicamentosa realizada: verificar o que mudou da admissão para a alta           |
| <input type="checkbox"/> | Medicamentos de alto risco revisados (anticoagulante, insulina, digital, antiarrítmico)        |
| <input type="checkbox"/> | Encaminhamentos / referência ambulatorial realizados ou agendados                              |
| <input type="checkbox"/> | AIH e documentação hospitalar preenchidas e entregues                                          |
| <input type="checkbox"/> | Vacinação verificada e orientações fornecidas                                                  |

### ■ ENFERMAGEM

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Paciente identificado com nome e data de nascimento antes da alta             |
| <input type="checkbox"/> | Acessos venosos, sondas, drenos retirados ou conduta orientada se permanentes |
| <input type="checkbox"/> | Pertences pessoais devolvidos ao paciente / acompanhante                      |
| <input type="checkbox"/> | Alta de enfermagem registrada no prontuário com horário                       |
| <input type="checkbox"/> | Condições do leito e sala comunicadas para limpeza / desinfecção              |
| <input type="checkbox"/> | Cuidador / responsável presente e orientado                                   |
| <input type="checkbox"/> | Folha de medicamentos entregue ao paciente / acompanhante                     |

### ■ PACIENTE / CUIDADOR

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Paciente (ou cuidador) verbaliza entender o diagnóstico em linguagem simples      |
| <input type="checkbox"/> | Paciente demonstra saber tomar os medicamentos corretamente (o que, quando, como) |
| <input type="checkbox"/> | Paciente sabe quais são os sinais de alarme para retorno de urgência              |
| <input type="checkbox"/> | Retorno agendado comunicado: data ____/____/____ — Local: _____                   |
| <input type="checkbox"/> | Número de contato de emergência fornecido (SAMU 192 / UPA / Hospital)             |

Alta concedida por: \_\_\_\_\_ CRM: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Hora da alta: \_\_\_\_:\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Referências: Joint Commission International Accreditation Standards 2023; Kripalani S et al. Arch Intern Med 2007; Coleman EA et al. Care Transitions Interventions. Ann Intern Med 2006.